CHƯƠNG TRÌNH CUNG CẤP KIẾN THỨC CĂN BẢN

VỀ QUẢN TRỊ BỆNH VIỆN

ĐỂ KHAI THÁC HỆ ĐIỀU HÀNH FMFT AIOS/LSE

LỜI MỞ ĐẦU

FMFT AIOS/LSE là một Hệ thống quản trị hiện đại trên nền tảng khai thác công nghệ AI tiên tiến để hỗ trợ vận hành qui trình của bệnh viện, đo đó muốn vận hành tốt Hệ thống cần có nền tảng kiến thức căn bản về quản trị Bệnh viện để khai thác hiệu quả tối đa của Hệ điều hành này.

ĐỀ CƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

BAN LÃNH ĐẠO BỆNH VIỆN

Tổ chức hệ thống quản trị bệnh viện tiên tiến và vận hành hiệu quả FMFT AIOS/LSE

I. Quan điểm thiết kế chương trình

Chương trình này không chỉ nhằm giúp Ban Lãnh đạo biết sử dụng phần mềm hay đọc dashboard. Mục tiêu cao hơn là giúp lãnh đạo hiểu đúng hệ thống quản trị, tổ chức lại cách vận hành bệnh viện và sử dụng FMFT AIOS/LSE như một hệ điều hành hỗ trợ quản trị, ra quyết định, hành động, kiểm soát rủi ro và học tập liên tục.

Chương trình được xây dựng trên bốn nguyên tắc:

1. Hiểu quản trị trước khi điều khiển công nghệ: Người sử dụng AI phải hiểu mục tiêu, cấu trúc tổ chức, quy trình, quyền hạn, KPI, dữ liệu và trách nhiệm.
2. Quản trị toàn bệnh viện, không chỉ quản lý từng khoa: Lấy chuỗi giá trị, hành trình người bệnh và kết quả toàn hệ thống làm trọng tâm.
3. Tích hợp Tổ chức – Con người – AI: Công nghệ không thay thế trách nhiệm của lãnh đạo, bác sĩ và nhân viên; công nghệ giúp tăng năng lực của hệ thống và con người.

4. Đo lường được, kiểm chứng được, cải tiến được: Mọi thay đổi phải có dữ liệu ban đầu, mục tiêu, người chịu trách nhiệm và tiêu chuẩn nghiệm thu.

Chương trình kết hợp nội dung quản trị trong General Manager Manual – Hospital với khung quản trị FMFT, KSEQ, AIOS/LSE và các nội dung mở rộng về quản trị chuỗi giá trị, luồng người bệnh, quản trị thay đổi và AI có kiểm soát.

II. Đối tượng, thời lượng và đầu ra

Đối tượng

Giám đốc bệnh viện, Phó Giám đốc, lãnh đạo khối chuyên môn, điều dưỡng, quản lý vận hành, quản lý chất lượng, tài chính, nhân sự, CNTT và nhóm triển khai FMFT AIOS/LSE.

Thời lượng đề xuất

2 ngày đào tạo tập trung, kết hợp 4–8 tuần thực hành tại bệnh viện. Các buổi thực hành tiếp theo được tổ chức theo tiến độ triển khai thực tế.

Đầu ra bắt buộc

Mỗi bệnh viện hoàn thành bản đồ chuỗi giá trị, bản đồ luồng người bệnh ưu tiên, bộ KPI và dashboard có từ điển KPI, ma trận trách nhiệm, kế hoạch quản trị thay đổi và kế hoạch vận hành FMFT AIOS/LSE có tiêu chuẩn nghiệm thu.

III. Cấu trúc chương trình đào tạo

Bao gồm 10 chuyên đề liên kết với nhau, đi từ tư duy quản trị nền tảng đến thiết kế hệ thống, vận hành FMFT AIOS/LSE và cải tiến liên tục.

01

Tư duy hệ thống và quản trị căn bản trong bệnh viện

Thời lượng: 90 phút

- Phân biệt quản trị, quản lý, lãnh đạo, điều hành và kiểm soát.
- Phân biệt mục tiêu, chiến lược, quy trình, nhiệm vụ, KPI, kết quả và trách nhiệm.
- Hiểu cấu trúc nhân quả: mục tiêu → hệ thống → quy trình → hoạt động → kết quả → phản hồi.
- Phân biệt vấn đề triệu chứng với nguyên nhân gốc.
- Hiểu vì sao AI không thể được điều khiển hiệu quả bằng các câu lệnh thiếu logic quản trị.

Bài tập: Phân tích một vấn đề thực tế của bệnh viện và xác định mục tiêu, nguyên nhân, chủ thể chịu trách nhiệm, dữ liệu cần thiết và hành động.

02

Môi trường cạnh tranh và nhu cầu đổi mới bệnh viện

Thời lượng: 60 phút

- Phân tích nhu cầu người bệnh, đối thủ, xu hướng công nghệ, chi phí và tiêu chuẩn chất lượng.
- Nhận diện giới hạn của quản trị theo từng khoa, từng chức năng.
- Phân biệt bảo vệ lợi ích cục bộ với bảo vệ lợi ích toàn bệnh viện.
- Phân tích sự chống đối thay đổi: lo mất quyền hạn, thiếu năng lực, chưa hiểu mô hình hoặc có phản biện chuyên môn chính đáng.
- Vai trò của giám đốc trong thiết lập mục tiêu chung, cơ chế trách nhiệm và văn hóa cải tiến.

Bài tập: Phân tích một điểm yếu trong mô hình hiện tại và xác định hậu quả khi bệnh viện không đổi mới.

03

Quản trị chuỗi giá trị và luồng người bệnh

Thời lượng: 90 phút

- Chuỗi giá trị bệnh viện: các hoạt động trực tiếp và hỗ trợ tạo ra giá trị cho người bệnh.
- Phân biệt tối ưu hóa từng khoa với tối ưu hóa toàn bộ hành trình.
- Lập bản đồ luồng người bệnh: tiếp nhận, phân luồng, khám, chẩn đoán, điều trị, ra viện và theo dõi.
- Phân tích thời gian xử lý, thời gian chờ, điểm bàn giao, nút thắt và nguồn lực nhàn rỗi.
- Thiết lập cơ chế phối hợp xuyên khoa, xuyên bộ phận.

Bài tập: Lập bản đồ hành trình người bệnh ngoại trú hoặc một quy trình cấp cứu; xác định ba điểm nghẽn lớn nhất dựa trên dữ liệu.

04

Thiết kế hệ thống quản trị và phân định trách nhiệm

Thời lượng: 60 phút

- Liên kết chiến lược, kế hoạch hoạt động năm (AOP), ngân sách, KPI và báo cáo quản trị.
- Xác định quyền quyết định, quyền phê duyệt, trách nhiệm thực thi và cơ chế leo thang.
- Phân biệt trách nhiệm lâm sàng với trách nhiệm điều phối vận hành.
- Thiết kế cơ chế phối hợp giữa Ban Giám đốc, trưởng khoa, điều dưỡng, chất lượng, tài chính và CNTT.
- Thiết lập lịch họp điều hành và theo dõi hành động sau họp.

Bài tập: Lập ma trận RACI cho một quy trình có sự tham gia của nhiều khoa.

05

Hệ thống KPI, dashboard và đo lường hiệu quả

Thời lượng: 90 phút

- Phân biệt KPI đầu vào, quá trình, kết quả; chỉ báo dẫn dắt và chỉ báo kết quả.
- Chuẩn hóa tên KPI, định nghĩa, công thức, tử số, mẫu số, nguồn dữ liệu, tần suất, chủ sở hữu và ngưỡng cảnh báo.
- Kết nối KPI với chất lượng lâm sàng, an toàn người bệnh, thời gian, năng suất, tài chính và trải nghiệm.
- Phân biệt dashboard điều hành, báo cáo phân tích và cảnh báo cần hành động.
- Tránh KPI xung đột, chạy theo chỉ tiêu, tối ưu cục bộ và diễn giải dữ liệu sai.

Bài tập: Xây dựng bộ KPI cho một quy trình; kiểm tra xem mỗi KPI có định nghĩa, dữ liệu, người chịu trách nhiệm và hành động khi lệch chuẩn hay chưa.

06

Quản trị chất lượng, an toàn và rủi ro

Thời lượng: 60 phút

- Quản trị chất lượng và an toàn như trách nhiệm xuyên suốt chuỗi giá trị.
- Nhận diện rủi ro, phân tích nguyên nhân gốc, FMEA, biện pháp kiểm soát trọng yếu và hành động khắc phục/phòng ngừa.
- Phân biệt tương quan dữ liệu với quan hệ nhân quả.
- Thiết lập cơ chế cảnh báo, xác minh, xử lý và ghi nhận kết quả.
- Không đánh đổi an toàn lâm sàng để đạt chỉ tiêu tốc độ, công suất hoặc tài chính.

Bài tập: Phân tích một sự cố hoặc tình huống suýt xảy ra sự cố; lập kế hoạch kiểm soát và đo hiệu quả sau can thiệp.

07

FMFT và KSEQ: Tổ chức, năng lực con người và vai trò AI

Thời lượng: 60 phút

- FMFT: Fundamental – Management – Functional – Technical.
- KSEQ: Knowledge – Skills – Experience – Quality/Character.
- Thiết kế năng lực theo vai trò và nhiệm vụ thực tế, không chỉ theo chức danh.
- Đánh giá mức độ sẵn sàng của người thực hiện nhiệm vụ và nhu cầu hỗ trợ, giám sát hoặc leo thang.
- Xem AI như một năng lực cần được giao nhiệm vụ, kiểm soát, đánh giá và giám sát, không phải chủ thể có quyền tự quyết định lâm sàng.

Bài tập: Xây dựng ma trận năng lực cho một vai trò trong quy trình cấp cứu hoặc điều trị chuyên khoa.

08

Kiến trúc và nguyên lý vận hành FMFT AIOS/LSE

Thời lượng: 90 phút

- Phân biệt AIOS — hệ điều hành hỗ trợ quản trị và vận hành — với LSE, động cơ hỗ trợ phát hiện và xử lý tình huống ưu tiên cao theo phạm vi được thiết kế.
- Kiến trúc năm lớp: hạ tầng CNTT; dữ liệu và tích hợp; trí tuệ FMFT/KSEQ/tri thức/quy tắc/AI; quyết định và hành động; quản trị và KPI.
- Chu trình LSE: Detect → Assess → Predict → Decide → Alert → Act → Verify → Learn.
- Kiểm soát nguồn tri thức, phiên bản, tính đầy đủ và chính xác của dữ liệu, thẩm định chuyên môn và khả năng truy vết.
- Cơ chế con người xác minh, quyết định, thực hiện và ghi nhận kết quả.

Bài tập: Theo dấu một cảnh báo từ dữ liệu đầu vào đến quyết định của người có thẩm quyền, hành động thực tế và xác minh kết quả.

09

Điều hành thực tế: từ dashboard đến hành động

Thời lượng: 60 phút

- Cách đọc dashboard và xác định sai lệch cần ưu tiên.
- Phân tích nguyên nhân, xác định người chịu trách nhiệm, thời hạn và hành động.
- Thiết kế luồng cảnh báo theo mức độ nghiêm trọng và thẩm quyền xử lý.
- Phân biệt cảnh báo cần xác minh, cảnh báo cần hành động và quyết định phải do con người thực hiện.
- Kiểm tra hiệu quả sau can thiệp và cập nhật tri thức đã được phê duyệt.

Bài tập: Mô phỏng cuộc họp điều hành bệnh viện từ dashboard; mỗi vấn đề phải có quyết định, người phụ trách, hạn hoàn thành và tiêu chuẩn xác nhận.

10

Quản trị thay đổi và triển khai cải tiến

Thời lượng: 60 phút

- Phân tích sự chống đối công khai và ngầm; phân biệt phản biện có căn cứ với hành vi cản trở.
- Truyền thông mục tiêu, phân định vai trò mới, đào tạo và hỗ trợ chuyển đổi.
- Chọn phạm vi thí điểm vừa đủ, thiết lập số liệu ban đầu và tiêu chí an toàn.
- Đo lường trước/sau, nghiệm thu, chuẩn hóa và mở rộng theo bằng chứng.
- Thiết lập kế hoạch cải tiến 90 ngày và cơ chế giám sát của Ban Lãnh đạo.

Bài tập: Hoàn thiện kế hoạch triển khai một cải tiến có sử dụng FMFT AIOS/LSE tại bệnh viện.

IV. Lộ trình đào tạo và thực hành

Khóa học tổ chức hai ngày tập trung, sau đó áp dụng trực tiếp tại bệnh viện. Không kết thúc chương trình chỉ bằng bài kiểm tra kiến thức.

Ngày 1

Hiểu hệ thống quản trị

Chuyên đề 1–5: tư duy quản trị, cạnh tranh và đổi mới, chuỗi giá trị, phân quyền, KPI và dashboard.

Đầu ra: sơ đồ chuỗi giá trị, bản đồ luồng người bệnh, danh mục vấn đề ưu tiên và bản nháp KPI.

Ngày 2

Tổ chức và điều hành FMFT AIOS/LSE

Chuyên đề 6–10: chất lượng và rủi ro, FMFT/KSEQ, kiến trúc AIOS/LSE, điều hành theo cảnh báo và quản trị thay đổi.

Đầu ra: ma trận trách nhiệm, mô hình vận hành AIOS/LSE, quy trình xử lý cảnh báo và kế hoạch thí điểm.

Tuần 1–2

Khảo sát và chuẩn hóa

Xác định quy trình ưu tiên, dữ liệu hiện có, KPI, quy chế, tri thức lâm sàng và các khoảng trống cần khắc phục.

Đầu ra: báo cáo hiện trạng, danh mục dữ liệu và tri thức cần chuẩn hóa, kế hoạch triển khai được phê duyệt.

Tuần 3–6

Thực hành vận hành

Chạy thử dashboard, quy trình cảnh báo, phối hợp liên khoa và cơ chế ra quyết định; kiểm tra chất lượng dữ liệu và các tình huống rủi ro.

Đầu ra: kết quả kiểm thử, nhật ký xử lý, danh sách lỗi và phương án khắc phục.

Tuần 7–8

Đánh giá và nghiệm thu giai đoạn

Đối chiếu kết quả với số liệu ban đầu, đánh giá an toàn, hiệu quả vận hành, năng lực người dùng và mức độ đáp ứng yêu cầu hệ thống.

Đầu ra: biên bản nghiệm thu, kế hoạch sửa lỗi, chuẩn hóa và đề xuất mở rộng hoặc tiếp tục thí điểm.

Thời gian thực tế cần điều chỉnh theo quy mô bệnh viện, mức độ sẵn sàng của dữ liệu, phạm vi LSE và tình trạng tích hợp CNTT. Đối với ứng dụng hỗ trợ quyết định lâm sàng, chỉ đưa vào vận hành chính thức sau khi hoàn thành các bước thẩm định, kiểm thử và phê duyệt cần thiết.

V. Các tài liệu phải chuẩn bị cho chương trình

Chuẩn bị một bộ tài liệu đào tạo thống nhất gồm tám sản phẩm:

01

Sổ tay quản trị bệnh viện theo FMFT

Khái niệm, nguyên lý, mô hình tổ chức, quyền hạn và trách nhiệm.

02

Bản đồ chuỗi giá trị và luồng người bệnh

Mẫu vẽ quy trình, đo thời gian, xác định điểm nghẽn và điểm bàn giao.

03

KPI Library và KPI Dictionary

Danh mục KPI, công thức, nguồn dữ liệu, chủ sở hữu, ngưỡng và hành động.

04

FMFT/KSEQ Competency Framework

Chuẩn năng lực theo vai trò, nhiệm vụ, mức độ sẵn sàng và nhu cầu hỗ trợ.

05

FMFT AIOS/LSE Operating Manual

Kiến trúc, chu trình vận hành, cảnh báo, phân quyền, kiểm soát và học tập.

06

Clinical Governance & Safety Pack

Quản trị tri thức lâm sàng, thẩm định, quản lý phiên bản, rủi ro và kiểm thử.

07

Bộ biểu mẫu điều hành

Dashboard, biên bản họp, action tracker, RCA, CAPA và nhật ký quyết định.

08

Pilot Governance & Acceptance Pack

WBS, RACI, mốc triển khai, tiêu chí nghiệm thu và kế hoạch mở rộng.

VI. Cơ chế quản trị để FMFT AIOS/LSE vận hành hiệu quả

Đào tạo chỉ tạo ra giá trị khi bệnh viện có cơ chế tổ chức thực thi. Tôi đề xuất mô hình quản trị triển khai như sau:

Ban Chỉ đạo

Giám đốc bệnh viện và các lãnh đạo có thẩm quyền

PMO / Nhóm điều phối dự án

Tiến độ · Nguồn lực · Rủi ro · Phối hợp · Nghiệm thu

Nhóm lâm sàng

Tri thức, phác đồ, an toàn, phê duyệt chuyên môn.

Nhóm FMFT

Chuỗi giá trị, KSEQ, KPI, quy trình và đào tạo.

Nhóm AI Engineering

AI, tích hợp logic, kiểm thử và đánh giá mô hình.

Nhóm CNTT bệnh viện

Dữ liệu, HIS, hạ tầng, thiết bị, mạng và bảo mật.

Vận hành có con người kiểm soát

Phát hiện → Đánh giá → Cảnh báo → Con người quyết định → Hành động → Xác minh → Học tập

Ban Chỉ đạo chịu trách nhiệm về mục tiêu và nguồn lực. Nhóm lâm sàng chịu trách nhiệm đối với tri thức và quyết định chuyên môn theo thẩm quyền. Nhóm FMFT chuẩn hóa hệ thống quản trị. Nhóm AI Engineering chịu trách nhiệm kỹ thuật và kiểm thử AI. Nhóm CNTT chịu trách nhiệm hạ tầng, tích hợp và an toàn hệ thống theo phạm vi được giao.

VII. Tiêu chuẩn đánh giá kết quả đào tạo và vận hành

Không đánh giá thành công chỉ bằng số người tham dự, số tài khoản được cấp hay số dashboard đã xây dựng. Cần đánh giá ở ba cấp độ:

Cấp độ	Tiêu chí đánh giá
Năng lực lãnh đạo	Hiểu chuỗi giá trị, phân tích KPI, phân quyền, ra quyết định và quản trị thay đổi
Năng lực hệ thống	KPI có định nghĩa thống nhất; dữ liệu có nguồn và chủ sở hữu; cảnh báo có quy trình xử lý; quyết định có khả năng truy vết
Kết quả vận hành	Các chỉ tiêu ưu tiên cải thiện theo số liệu thực tế, đồng thời duy trì hoặc cải thiện các yêu cầu an toàn và chất lượng

Mỗi KPI cải tiến phải có số liệu nền, mục tiêu, thời hạn, người chịu trách nhiệm, nguồn dữ liệu và cách xác minh. Không đặt mục tiêu giảm thời gian chờ, chi phí hay thời gian nằm viện một cách máy móc mà không xét đến chất lượng và an toàn.

VIII. Kết luận: Năng lực mà Ban Lãnh đạo cần đạt được

Sau chương trình, Ban Lãnh đạo phải có khả năng thực hiện năm việc:

1. Thiết kế: Tổ chức hệ thống quản trị bệnh viện theo chuỗi giá trị và mục tiêu chung.
2. Đo lường: Xây dựng KPI và dashboard phản ánh đúng tình trạng vận hành.
3. Điều hành: Chuyển thông tin thành quyết định, hành động, trách nhiệm và kết quả kiểm chứng.
4. Kiểm soát: Vận hành FMFT AIOS/LSE trong phạm vi được phê duyệt, với con người chịu trách nhiệm đối với các quyết định thuộc thẩm quyền.
5. Cải tiến: Phân tích dữ liệu, khắc phục nguyên nhân gốc, phát triển năng lực con người và chuẩn hóa các cải tiến đã được xác nhận.

Thông điệp kết thúc khóa học:

Giám đốc bệnh viện không chỉ quản lý các khoa và phòng ban. Giám đốc phải tổ chức một hệ thống thống nhất để toàn bộ bệnh viện tạo ra giá trị tốt nhất có thể cho người bệnh.

FMFT cung cấp cấu trúc tư duy và quản trị; AIOS kết nối tổ chức, con người, dữ liệu và công nghệ thành hệ thống vận hành; LSE hỗ trợ phát hiện, đánh giá và xử lý những tình huống ưu tiên cao trong phạm vi được thiết kế. Hiệu quả cuối cùng phải được chứng minh bằng hành động thực tế, kết quả đo lường được và sự an toàn của người bệnh.

Theo tôi, đây nên là chương trình đào tạo nền tảng bắt buộc trước khi giao cho Ban Lãnh đạo trách nhiệm điều hành FMFT AIOS/LSE, đồng thời là bộ khung để đào tạo tiếp các trưởng khoa và đội ngũ vận hành.

----------oOo----------